Компас

Цифровой ассистент врача первичного звена для взрослых с тревогой и депрессией

Команда «Мозгобойня»
Хакатон «Клинический компас», 2026

1 · ИДЕЯ

Пациент с тревогой и депрессией под наблюдением между приёмами

ШАГ 1 **Измерение** — PHQ-9, GAD-7, дневник, отметки приёма, нежелательные явления

→

ШАГ 2 **Правила** — у каждого источник: КР, инструкция, статья

→

ШАГ 3 **Сигнал врачу** — срочное сразу; не принят вовремя, уходит заместителю

→

ШАГ 4 **Решение врача** — подтвердить, изменить, отклонить с причиной

→

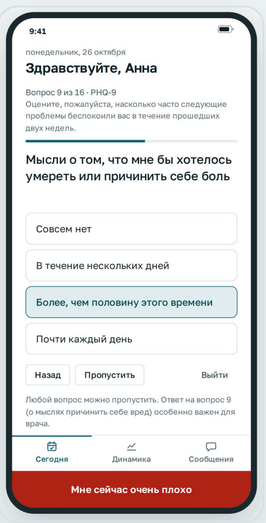
ШАГ 5 **Наблюдение** — динамика, отмены, приверженность, НЯ

Регулярное измерение симптомов (measurement-based care) повышает шанс ремиссии депрессии: OR 1,83 (95 % ДИ 1,12–2,97), 7 РКИ, 2019 пациентов.
Zhu M. et al. J Clin Psychiatry. 2021;82(5):21r14034

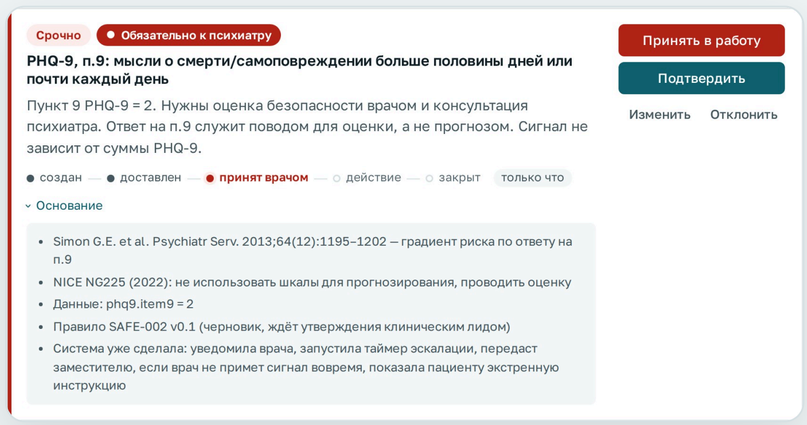
Не чат-бот-психолог: Компас не ставит диагноз, не назначает и не отменяет лечение. Решает врач.

2 · ПРОТОТИП

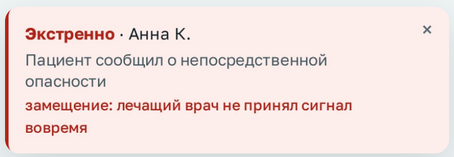
Вопрос 9 сразу доходит до врача



Пациентка отвечает на п.9 PHQ-9



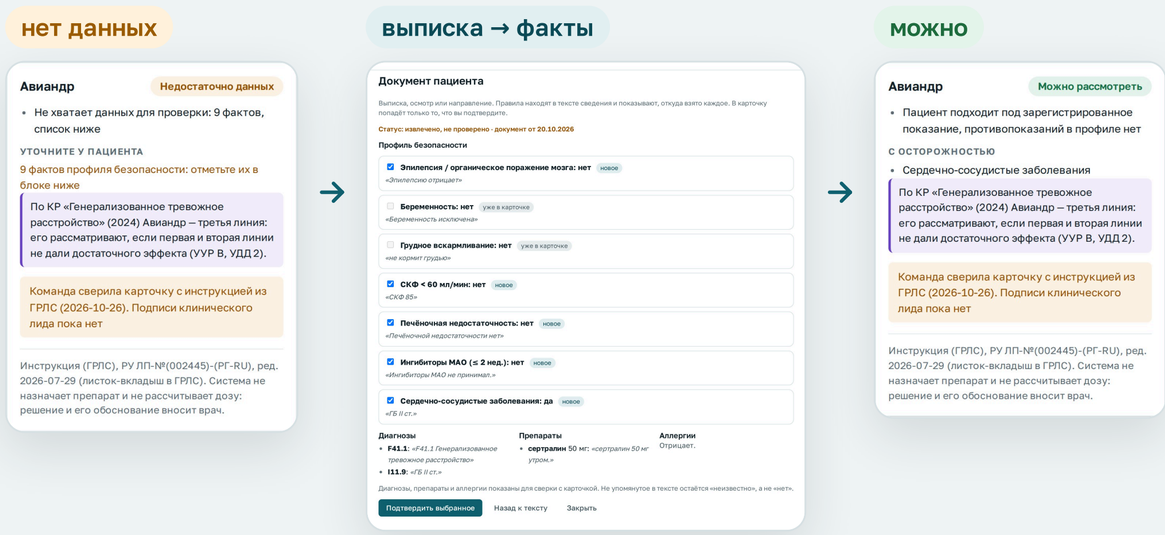
Врачу за 14 мс приходит срочный сигнал с основанием и источниками



Не принят за 60 с: сигнал получает заместитель с доступом только к этому пациенту. Решение врача с причиной пишется в журнал

2 · ПРОТОТИП

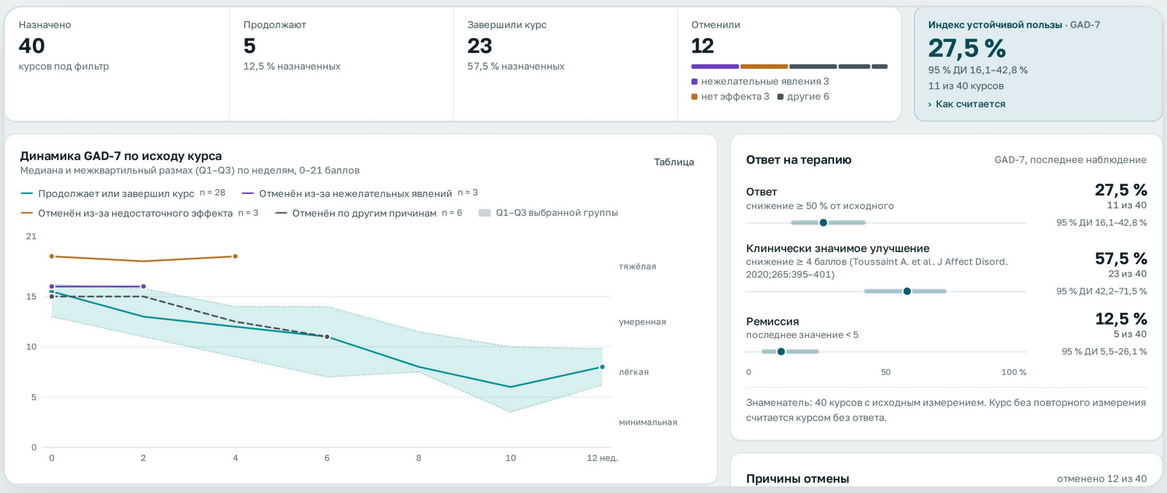
Авиандр строго по инструкции



- **Три статуса:** можно рассмотреть, не подходит, недостаточно данных. Карточка сверена с инструкцией ГРЛС.
- **По КР «ГТР» 2024** Авиандр относится к третьей линии, и система пишет об этом прямо.

2 · ОТЛИЧИЕ

Наблюдение применения препарата



- **Индекс устойчивой пользы:** ответ без отмены из-за вреда среди всех начавших (ITT, 95 % ДИ).
- **Исследователь** видит только обезличенные сводки, группы меньше 5 человек скрыты.

3 · МЕТРИКИ

Сигнал доходит, данные не теряются

0 из 387
самоотчётов потеряно
kill -9 сервера посреди потока, подъём за 2,6 с

100
сессий без ошибок
одновременно; p95 любого экрана ≤ 1,8 с

14 мс
до сигнала у врача
медиана; потерь 0 из 200

0,89 / 0,93
чувствительность / специфичность
сигналов безопасности

0,96
F1 по препаратам
извлечение из выписок

369
автотестов
сервер, правила, интерфейс, права

Данные синтетические. Скрипты и сырые результаты лежат в evaluation/.

4 · ПЛАНЫ

От прототипа к пилоту

1 **Экспертная проверка** — психиатр и клинический лид утверждают правила и пороги

2 **Теневой режим** — сигналы считаются, но врачу не показываются; сверка с его решениями

3 **Пилот** — одна поликлиника, заместители и регламент реакции на сигнал

Шкалы: PHQ-9 и GAD-7, валидированные русские версии (Золотарева, 2023). **КР Минздрава:** ГТР 2024 (ID 457_3), депрессивный эпизод (ID 301_3). **Безопасность:** NICE NG225 (2022); Simon G.E. 2013, градиент риска по п.9 PHQ-9. **ГРЛС:** инструкция Авиандра, сверенная командой. **Дальше технически:** МИС и ЕГИСЗ, статус медизделия, двухфакторный вход, PostgreSQL.

5 · КОМАНДА «МОЗГОБОЙНЯ»

Полусмак Илья
капитан · РНИМУ им. Н. И. Пирогова, медицинская кибернетика

Коршунов Евгений
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, медицинская кибернетика

Хабарова Ольга
НГУ, биология

Пономарев Матвей
МГУ, мехмат, прикладная математика и информатика

Кирсберг Арина
МГУ, мехмат, прикладная математика и информатика

Спасибо организаторам хакатона «Клинический компас» и экспертам за обратную связь.

github.com/ArinaPanfilova/clinical_compass